Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO - COLECISTITE E COLANGITE AGUDA

RESUMO **ESTRATÉGICO**

2024



INTRODUÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido Aluno, neste resumo estão os principais pontos que são cobrados sobre colecistite aguda e colangite aguda. Preparei esse material para você dar aquela última "revisada" antes da prova. Lembrando que é um resumo e que, se você quiser se aprofundar no assunto, ou se surgir alguma dúvida, nosso livro texto está bem completo e detalhado

Estratégia MED

@prof.renathapaiva

@estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

SUMÁRIO

COLECISTITE AGUDA 5
1.0 INTRODUÇÃO 5
2.0 EPIDEMIOLOGIA 5
3.0 FISIOPATOLOGIA 6
4.0 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 6
5.0 EXAMES COMPLEMENTARES 7
5.1 EXAMES LABORATORIAIS 7
5.2 EXAMES DE IMAGEM 7
5.3 ULTRASSONOGRAFIA 8
5.4 CINTILOGRAFIA 9
5.5 TOMOGRAFIA 9
5.6 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 10
6.0 COMPLICAÇÕES 11
6.1 COLECISTITE GANGRENOSA 11
6.2 PERFURAÇÃO 11
6.3 ABSCESSO HEPÁTICO 11
6.4 COLECISTITE ENFISEMATOSA 12
6.5 EMPIEMA DE VESÍCULA BILIAR 12
6.6 FÍSTULA COLECISTOENTÉRICA 13
6.7 ÍLEO BILIAR 13
6.8 SÍNDROME DE MIRIZZI 16
7.0 DIRETRIZES DE TOKYO 16
8.0 TRATAMENTO 18
8.1 TRATAMENTO SEGUNDO AS DIRETRIZES DE TOKYO 2018 18
8.2 COLECISTECTOMIA ABERTA X COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA 20
9.0 COLECISTITE AGUDA ALITIÁSICA 21
10.0 COLECISTITE AGUDA NA GESTANTE 22

COLANGITE AGUDA 23
11.0 INTRODUÇÃO 23
12.0 EPIDEMIOLOGIA 23
13.0 FISIOPATOLOGIA 23
14.0 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 24
15.0 EXAMES COMPLEMENTARES 24
15.1 EXAMES LABORATORIAIS 24
15.2 EXAMES DE IMAGEM 25
16.0 DIRETRIZES DE TOKYO 27
17.0 TRATAMENTO 28
17.1 DRENAGEM DA VIA BILIAR 28
17.2 TRATAMENTO DA CAUSA DA COLANGITE 32
18.0 LISTA DE QUESTÕES 33
19.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 34
20.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 34

COLECISTITE AGUDA

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

Colecistite crônica: infiltração celular inflamatória crônica da vesícula biliar, observada na histopatologia. Desenvolve-se após repetidos episódios de cólica biliar, que causam inflamação e estenose no colo vesical e no ducto cístico, levando a uma fibrose e espessamento da vesícula biliar. A apresentação clínica é de cólica biliar, dor em epigástrio ou hipocôndrio direito, que pode irradiar para a escápula, causada pela obstrução temporária do ducto cístico e tende a ocorrer após as refeições, principalmente as ricas em lipídios.

Colecistite aguda: síndrome de dor no quadrante superior direito, febre e leucocitose associada à inflamação da vesícula biliar. Na maioria dos casos (90%), a colecistite aguda desenvolve-se em pacientes com histórico de cálculos biliares sintomáticos, enquanto a colecistite acalculosa é responsável por cerca de 5% a 10% dos casos.

A diferenciação entre cólica biliar e colecistite aguda é o bloqueio não resolvido do ducto cístico. Na cólica biliar, a obstrução é temporária e, na colecistite é constante, gerando o processo inflamatório.

CAPÍTULO
2.0 EPIDEMIOLOGIA

Colecistite aguda = complicação mais comum da colelitíase (6% a 11% dos pacientes sintomáticos).

As mulheres são as mais acometidas, com relação de 3:1, mas essa diferença diminui a partir dos 50 anos. Já a colecistite aguda alitiásica é mais frequente em homens.

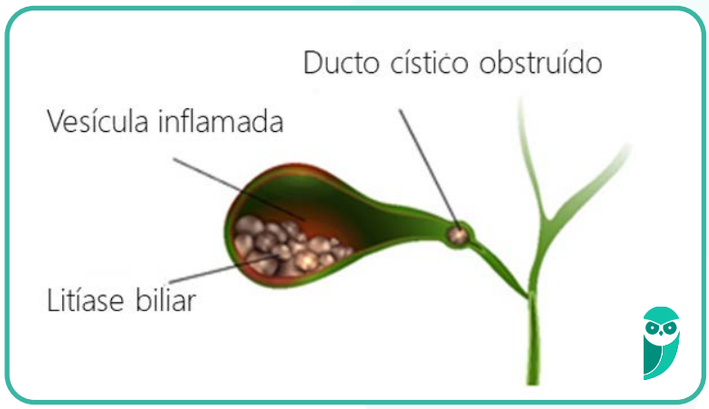
Vamos relembrar os principais fatores de risco para a colelitíase! Lembre-se do mnemônico dos 4 Fs, do inglês:

- Sexo feminino (Female)
- Idade > 40 anos (Forty)
- Obesidade/dislipidemia (Fat)
- Gravidez/multiparidade (Fertility)

A colecistite aguda é a segunda causa mais frequente de abdome agudo, não obstétrico, na gravidez. Apenas recordando: a primeira causa é a apendicite aguda. E, nos idosos, é indicação de cirurgia de urgência mais frequente.

CAPÍTULO

3.0 FISIOPATOLOGIA



Principal causa da colecistite aguda: obstrução do ducto cístico, geralmente por cálculo impactado no infundíbulo.

Outro fator importante: ação irritante da lisolecitina, que é produzida a partir da ação da enzima fosfolipase A2 presente na mucosa da vesícula biliar, sobre a lecitina, um constituinte normal da bile.

Lecitina (bile) → Foslipase A2 → **Lisolecitina** → = → **Inflamação da vesícula biliar**

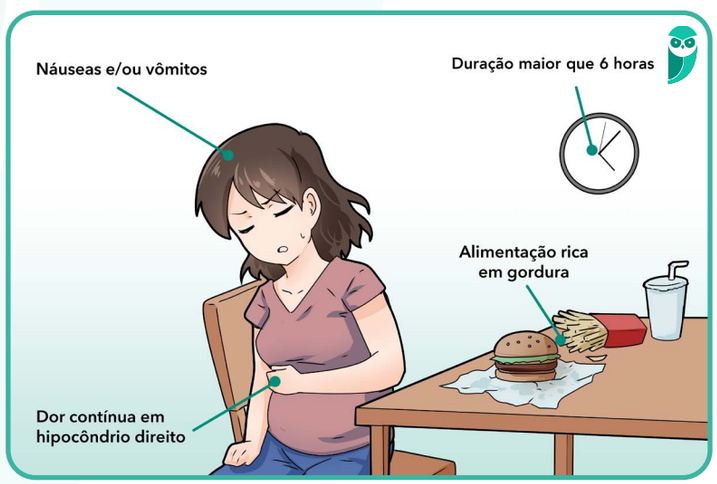
A infecção da bile "estagnada" é considerada um fenômeno secundário e nem sempre ocorre. Por isso, no início do quadro, a inflamação da colecistite é dita "estéril". As principais bactérias isoladas foram *Escherichia coli* (41%), *Enterococcus* (12%), *Klebsiella* (11%) e *Enterobacter* (9 %) e anaeróbios (ex: Bacterioides fragilis).

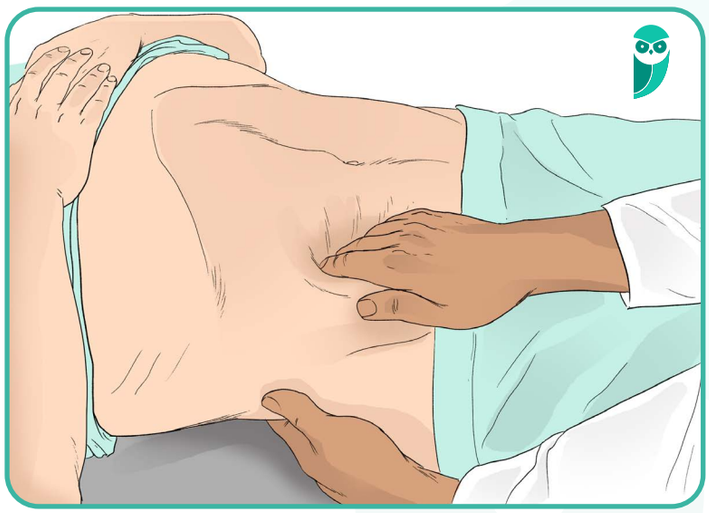
CAPÍTULO

4.0 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

Devemos pesquisar se há diagnóstico prévio de colelitíase ou história de cólicas biliares relacionadas à ingesta alimentar.

A dor da colecistite aguda é constante, intensa e geralmente prolongada, superior a 4 horas a 6 horas. Pode irradiar-se para o ombro direito (sinal de Kehr) ou para a escápula direita. Geralmente vem associada a febre, náuseas, vômitos e anorexia. Aproximadamente 10% dos pacientes apresentam icterícia leve por edema do colédoco adjacente, coledocolitíase associada ou pela síndrome de Mirizzi (obstrução do ducto hepático comum causada por compressão extrínseca de um cálculo impactado no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar).





Ao exame físico, pode haver febre, taquicardia, hipersensibilidade à palpação e defesa no quadrante superior direito. O sinal mais importante no exame físico, e que SEMPRE CAI EM PROVA, é **o "SINAL DE MURPHY",** que consiste na interrupção abrupta da inspiração durante a palpação profunda do rebordo costal direito, ou ponto cístico. Esse sinal tem alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de colecistite aguda.

COLECISTITE AGUDA

Sinal de Murphy: interrupção abrupta da inspiração profunda por dor à palpação do hipocôndrio direito.

COLECISTITE CLÁSSICA

- ✓ Dor em hipocôndrio direito constante, geralmente após ingesta alimentar
- ✓ Náuseas e vômitos
- ✓ Febre baixa
- ✓ Sinal de Murphy positivo
- ✓ Leucocitose

RESUMINDO

Em casos mais avançados, como na necrose e perfuração da vesícula, os pacientes podem apresentar sinais de sepse, peritonite generalizada, crepitação da parede abdominal (colecistite enfisematosa) e até uma obstrução intestinal (íleo biliar).

CAPÍTULO

5.0 EXAMES COMPLEMENTARES

5.1 EXAMES LABORATORIAIS

As principais alterações laboratoriais são:

- leucocitose com desvio à esquerda;
- aumento da proteína C reativa (PCR);
- elevações leve a moderada da fosfatase alcalina, amilase sérica, bilirrubinas e transaminases.

5.2 EXAMES DE IMAGEM

SEMPRE é necessário exame de imagem para confirmação diagnóstica através de sinais radiológicos típicos da colecistite aguda, como o espessamento ou edema da parede da vesícula biliar.

5.3 ULTRASSONOGRAFIA

Na maioria dos casos, o diagnóstico da colecistite aguda é estabelecido com uma ultrassonografia abdominal. Tem sensibilidade e especificidade de 85% e 95%, respectivamente. Devido a sua baixa invasividade, ampla disponibilidade, facilidade de uso e relação custo-benefício, a ultrassonografia é recomendada como o **método de imagem de primeira escolha para o diagnóstico de colecistite aguda**. Além de detectar a presença de cálculos biliares, pode apresentar os seguintes sinais:



ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS NA COLECISTITE AGUDA

✓ espessamento da parede vesicular (≥ 4 mm) ou edema (sinal da dupla parede);
✓ cálculo impactado e imóvel no infundíbulo;
✓ aumento da vesícula biliar - hidropsia (eixo longo ≥ 8 cm, eixo curto ≥ 4 cm);
✓ líquido perivesicular (halo hipoecoico);
✓ sinal de Murphy ultrassonográfico: hipersensibilidade na topografia da vesícula notada durante a palpação com o transdutor do ultrassom;
✓ presença de gás no fundo da vesícula (sinal de Champagne), indicativa de colecistite enfisematosa;
✓ líquido livre na cavidade (perfuração de vesícula com coleperitônio);



Espessamento da parede vesicular

Fonte: prova de acesso direto SUPREMA MG 2020.



Cálculo impactado no infundíbulo

Fonte: prova de acesso direto HCG 2018.

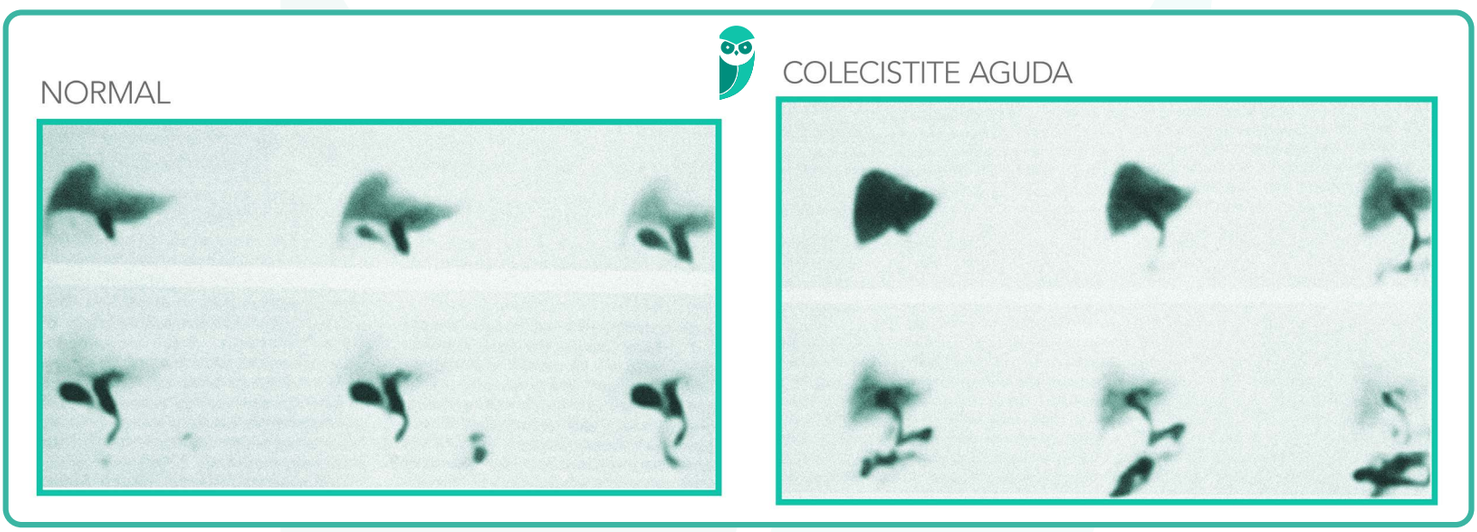
ULTRASSONOGRAFIA = PRIMEIRO EXAME SOLICITADO NA SUSPEITA DE COLECISTITE AGUDA

5.4 CINTILOGRAFIA

A cintilografia é considerado o exame de imagem **PADRÃO-OURO** na investigação quando a ultrassonografia é duvidosa. Tem sensibilidade e especificidade para colecistite aguda de aproximadamente 90% a 97% e 71% a 90 %, respectivamente, e é mais confiável em pacientes não ictéricos, com BT < 5 mg/dL. É realizada com a injeção intravenosa do ácido iminodiacético (HIDA) marcado com tecnécio 99m, que é absorvido seletivamente pelos hepatócitos e excretado na bile. Geralmente, a visualização do contraste no ducto biliar comum, na vesícula e no duodeno, ocorre dentro de 30 a 60 minutos. Se a vesícula não for visualizada, pode-se obter imagens tardias, após 3 a 4 horas, ou aplicar morfina, que determina a contração do esfíncter de Oddi, com consequente refluxo da bile através do colédoco. Se a vesícula biliar for preenchida após 30 minutos da aplicação da morfina, afasta o diagnóstico de colecistite aguda.

Apesar da melhor acurácia em relação ao ultrassom, tem como desvantagens: o alto custo; ser um exame demorado; e não estar disponível na maioria das instituições.

CINTILOGRAFIA = PADRÃO-OURO PARA O DIAGNÓSTICO DE COLECISTITE AGUDA
COLECISTITE AGUDA = VESÍCULA NÃO VISÍVEL



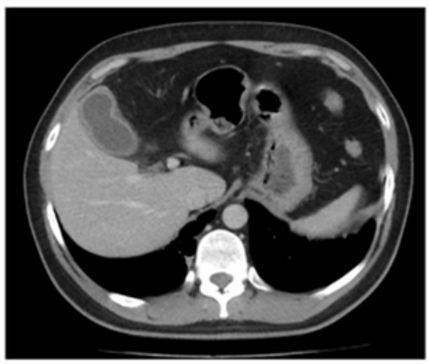
5.5 TOMOGRAFIA

A tomografia computadorizada abdominal não é rotineiramente necessária para diagnosticar colecistite aguda. Geralmente, é **solicitada para descartar complicações de colecistite aguda em pacientes com sepse**, ou seja, necrose ou gangrena da parede vesicular (mais comum), abscesso perivesicular (perfuração bloqueada), peritonite generalizada com coleperitônio (perfuração), empiema de vesícula, abscesso hepático, colecistite enfisematosa ou obstrução intestinal (íleo biliar). Mas lembre-se que a **tomografia é menos sensível que a ultrassonografia** para o diagnóstico de colecistite aguda. Tem a vantagem de descartar outras patologias, mas pode falhar na detecção de cálculos biliares, pois muitas pedras são isodensas com a bile (cálculos de colesterol).

ACHADOS TOMOGRÁFICOS QUE PODEM SER ENCONTRADOS NOS QUADROS DE COLECISTITE AGUDA

TOME NOTA!

✓ edema e espessamento de parede vesicular;
✓ realce da parede da vesícula;
✓ vesícula biliar túrgida, distendida;
✓ cálculo impactado no infundíbulo;
✓ líquido perivesicular ou livre na cavidade (coleperitônio);
✓ bile de alta atenuação;
✓ a presença de interface gás-bile, ou presença de ar em parede vesicular sugere que a bactéria relacionada seja do gênero *Clostridium*, indicativa de colecistite enfisematosa;
✓ perdas de contornos da vesícula biliar e realce heterogêneo do parênquima hepático.

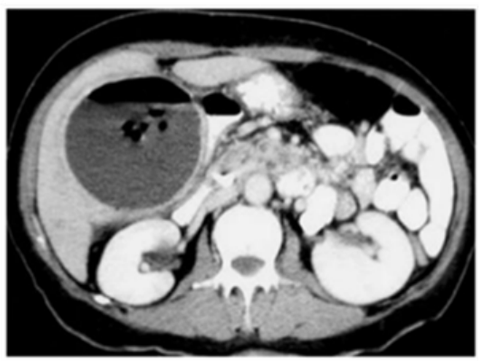


Espessamento da parede



Vesícula túrgida e paredes espessadas

Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Colecistite enfisematosa

Fonte: prova acesso direto SUPREMA MG 2020.

TOMOGRAFIA = AVALIAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DA COLECISTITE AGUDA

5.6 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Assim como a tomografia, estaria indicada quando o diagnóstico definitivo não é dado pela ultrassonografia e na suspeita de complicações. Como desvantagem, apresenta o alto custo e disponibilidade limitada na maioria dos serviços.

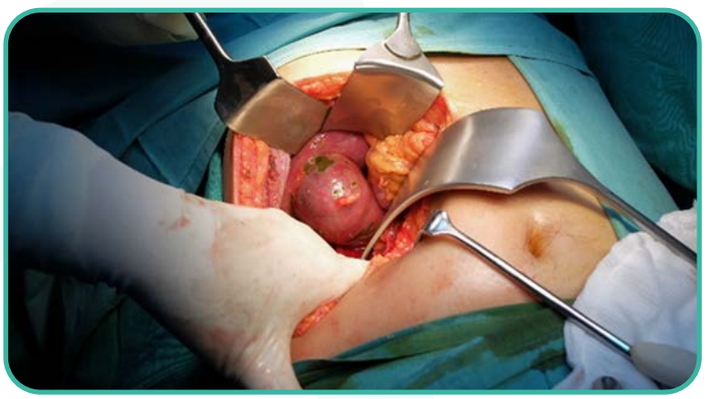
CAPÍTULO

6.0 COMPLICAÇÕES

A colecistite aguda pode apresentar uma série de complicações, algumas exigem tratamento cirúrgico de urgência, por isso é importante saber diagnosticá-las. Complicações como gangrena de parede, perfuração e colecistite enfisematosa são mais comuns na colecistite aguda alitiásica.

6.1 COLECISTITE GANGRENOSA

É a complicação mais comum da colecistite (até 20% dos casos), mais frequente na colecistite alitiásica. Acomete, principalmente, pacientes do sexo masculino, idosos e diabéticos.



Necrose parede vesicular.
Fonte: Shutterstock.

6.2 PERFURAÇÃO

É uma evolução da necrose da parede e ocorre, principalmente, no fundo da vesícula. Pode haver formação de abscesso perivesicular ou, se a perfuração for livre para a cavidade, coleperitônio com peritonite difusa, o que aumenta as taxas de mortalidade. A presença de coleperitônio exige tratamento cirúrgico de urgência (colecistectomia).

6.3 ABSCESSO HEPÁTICO

Ocorre por disseminação direta da infecção biliar (colecistite, colangite), que está presente em 40% a 60% dos casos de abscesso hepático. As manifestações clínicas típicas do abscesso hepático são febre, presente em 90% dos casos, e dor abdominal. Ultrassom e tomografia computadorizada são os exames de imagem normalmente usados para identificação de abscesso hepático. O tratamento consiste em antibioticoterapia e drenagem do abscesso hepático, cirurgicamente (aberto ou laparoscópico), por via percutânea ou via colangiopancreatografia endoscópica retrógrada.



Abscesso hepático lobo esquerdo.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Volumoso abscesso hepático lobo direito.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

6.4 COLECISTITE ENFISEMATOSA



Colecistite enfisematosa.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

Ocorre nos casos de colecistite aguda com infecção secundária da parede da vesícula por bactérias formadoras de gás, como o ***Clostridium*** (Ex: *Clostridium perfringens, Clostridium welchii)*. Outros organismos que podem ser isolados incluem *Escherichia coli* (15%), estafilococos, estreptococos, *Pseudomonas e Klebsiella*. A clínica é semelhante à da colecistite aguda, com instalação súbita e evolução rápida, e pode apresentar crepitação da parede abdominal, sendo este um sinal bastante sugestivo. Acomete principalmente homens, com idade superior a 60 anos e diabéticos. A TC de abdome contrastada é o melhor exame para o diagnóstico de colecistite enfisematosa, que demonstra a presença de interface gás-bile, ou ar na parede vesicular.

6.5 EMPIEMA DE VESÍCULA BILIAR

O termo “empiema” significa que o conteúdo vesicular é purulento. Normalmente, o paciente apresenta febre, além de massa palpável e dolorosa no hipocôndrio direito.

6.6 FÍSTULA COLECISTOENTÉRICA

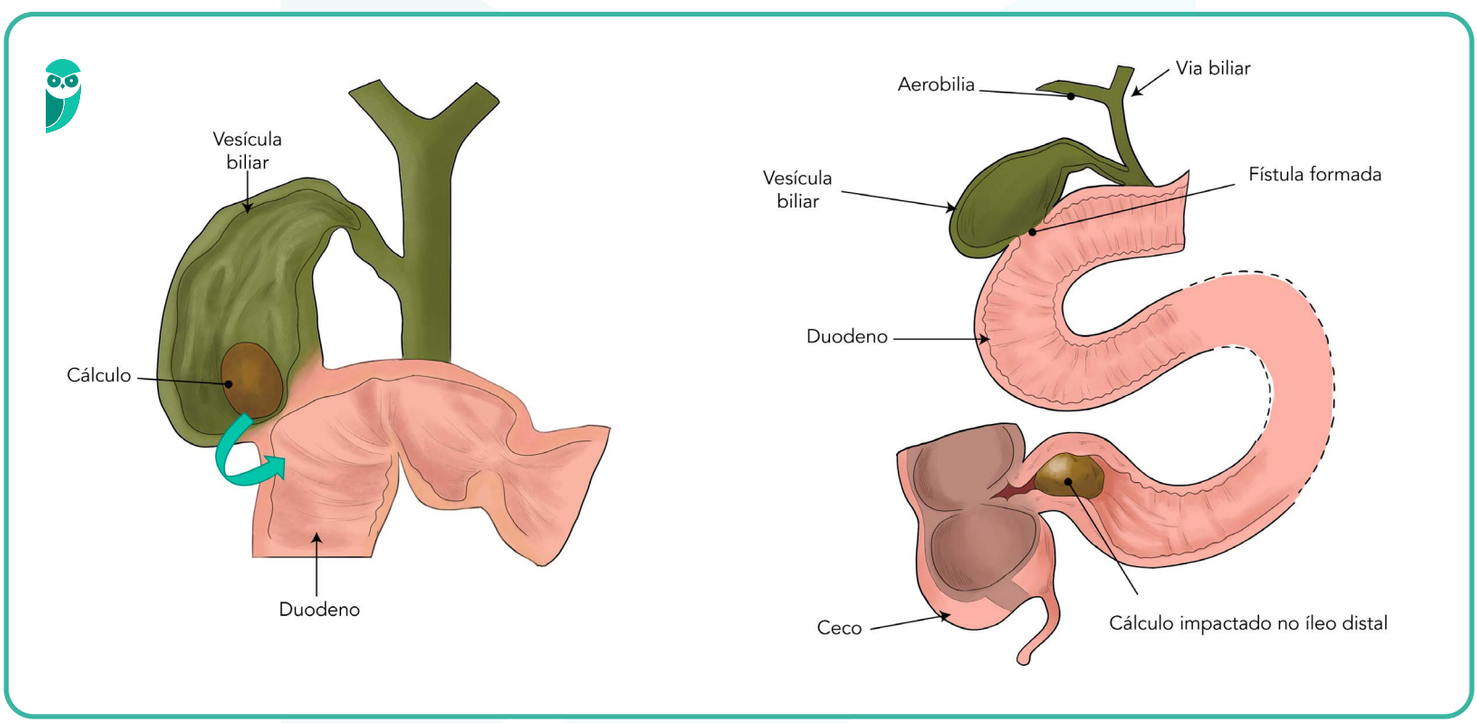
A fístula colecistoentérica complica 2% a 3% de todos os casos de litíase na vesícula biliar. Resulta da perfuração da vesícula biliar diretamente na luz intestinal. A maioria das fístulas são colecistoduodenais e aproximadamente 15% são colecistocolônicas (mais na flexão hepática).

6.7 ÍLEO BILIAR

O íleo biliar é uma complicação rara de litíase vesicular que ocorre com uma frequência de 0,3% a 0,5% dos casos e 2% a 3% na presença de colecistite aguda. Acomete, principalmente, pacientes do sexo feminino e idosos. Pode apresentar a síndrome de Mirizzi coexistente.

O íleo biliar caracteriza-se pela impactação de um ou mais cálculos no intestino. Decorre da passagem de um cálculo, geralmente maior que 2,5 cm, através de uma fístula colecistoduodenal, que geralmente se impacta no íleo terminal, próximo à válvula ileocecal, causando um quadro de obstrução intestinal alta, com dor e distensão abdominal associadas a vômitos biliosos. Apesar do termo "íleo biliar", o bloqueio mecânico pode acometer qualquer parte do intestino, sendo o mais comum o íleo distal, uma vez que este afunila antes de entrar no ceco.

Raramente, o cálculo biliar é impactado dentro do canal pilórico ou duodeno, causando obstrução da saída gástrica (síndrome de Bouveret). Os sintomas apresentados são início abrupto de dor epigástrica, náuseas e vômitos.



O diagnóstico é confirmado por exames de imagem, sendo a tomografia o exame de escolha. Os principais achados incluem:

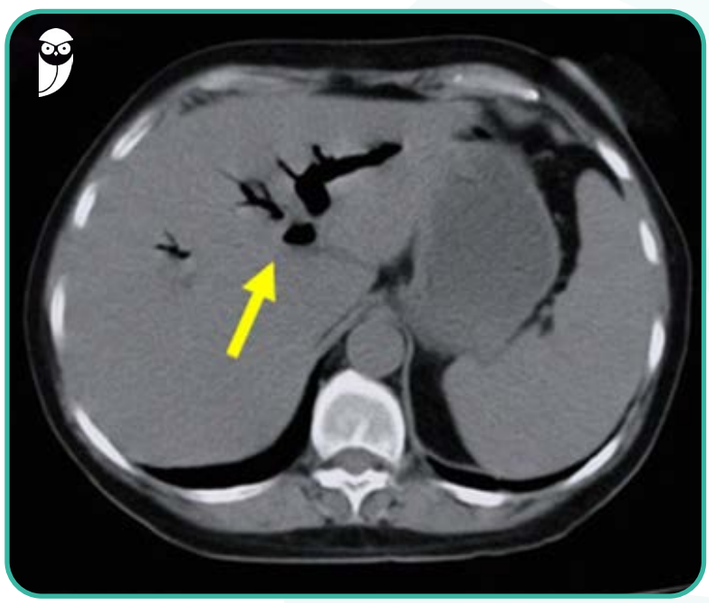
ACHADOS TOMOGRÁFICOS DO ÍLEO BILIAR

✓ Espessamento da parede da vesícula biliar.

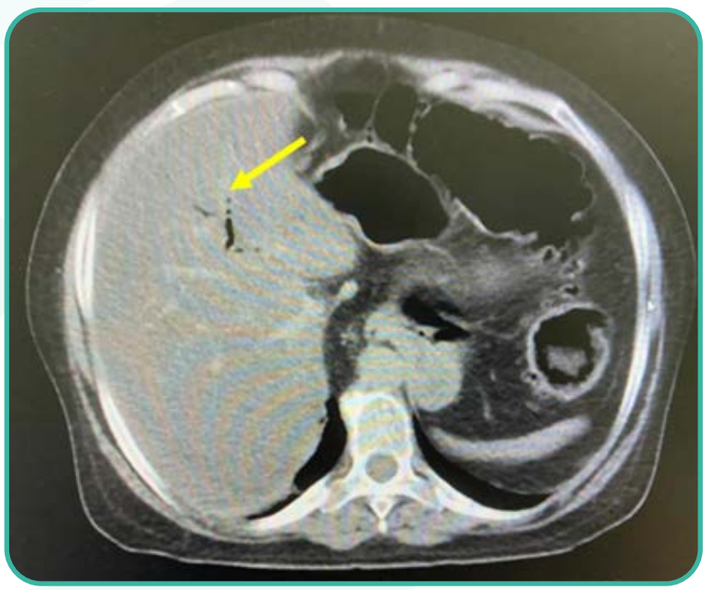
✓ Pneumobilia (aerobilia) – 30% a 60% dos pacientes, é um achado inespecífico.

✓ Padrão de obstrução intestinal alta (distensão de alças, níveis hidroaéreos, empilhamento de moedas).

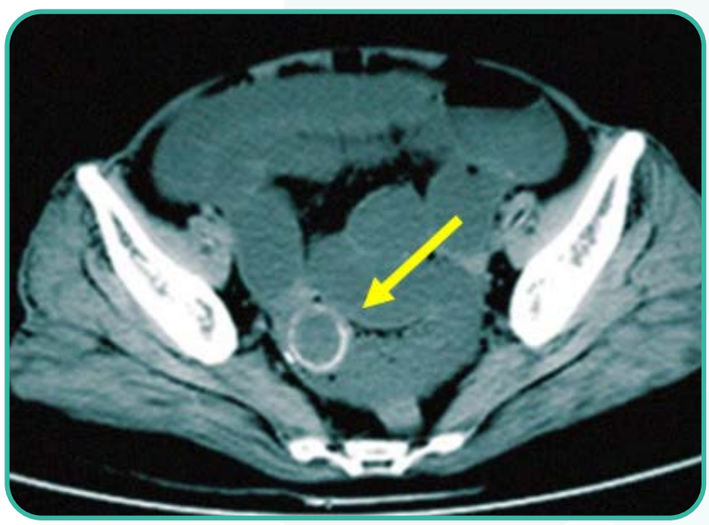
✓ Cálculo biliar > 2,5 cm impactado no íleo terminal.



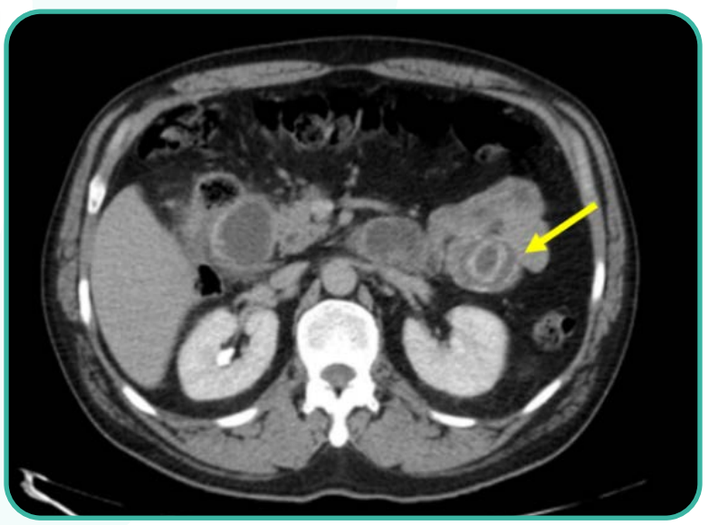
Aerobilia.



Aerobilia. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva



Cálculo impactado no íleo distal.
Fonte: imagem adaptada do UpToDate.



Cálculo impactado no jejuno.
Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.

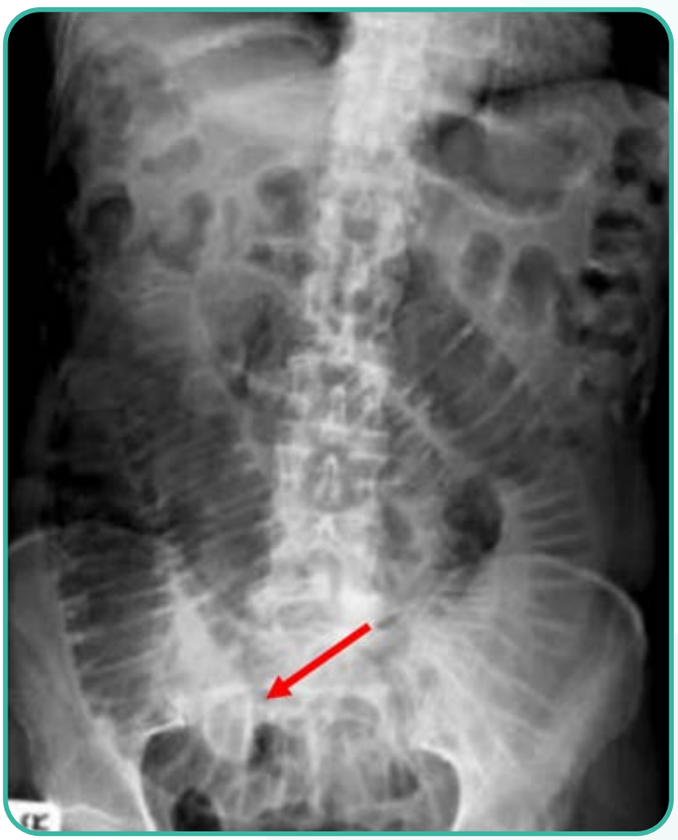
A radiografia simples de abdome também possui alguns achados típicos:

ACHADOS RADIOGRÁFICOS DO ÍLEO TERMINAL – TRÍADE DE RIEGLER

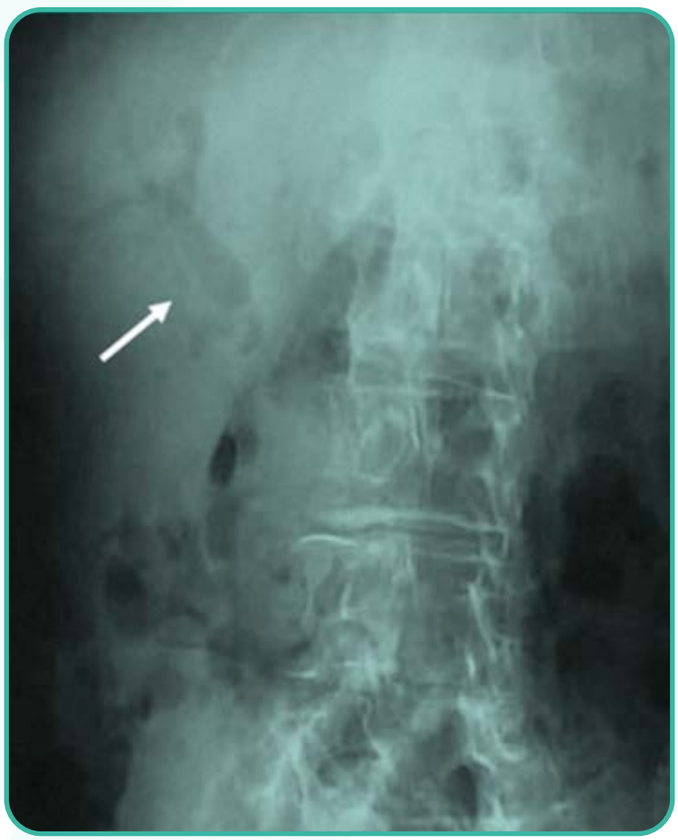
✓ Sinais de obstrução intestinal alta (distensão de alças, níveis hidroaéreos, "empilhamento de moedas").

✓ Pneumobilia (aerobilia) – difícil visualização à radiografia simples.

✓ Cálculo biliar ectópico, geralmente observado na fossa ilíaca direita (topografia do íleo terminal).



Cálculo ectópico (íleo terminal).
Fonte: prova de acesso direto - FAMEMA 2020.



Aerobilia.
Fonte: imagem adaptada do site geocites.ws.

O tratamento do íleo biliar é cirúrgico de urgência: laparotomia com enterotomia, retirada do cálculo e enterorrafia. Se houver isquemia ou perfuração do segmento intestinal, é necessária sua ressecção.

A colecistectomia e fechamento da fístula podem ser realizados em um único tempo cirúrgico se o paciente apresentar condições clínicas favoráveis (ASA I ou II). Já os pacientes graves, de alto risco (ASA III, IV ou V), podem ter o procedimento biliar adiado ou mesmo não realizado, uma vez que é possível fechamento espontâneo da fístula, principalmente se o ducto cístico estiver patente, ficando reservada a colecistectomia para sintomas recorrentes.

Na presença da síndrome de Bouveret isolada, em que o cálculo está impactado no piloro ou no duodeno, o procedimento de escolha é a litotripsia endoscópica do cálculo.

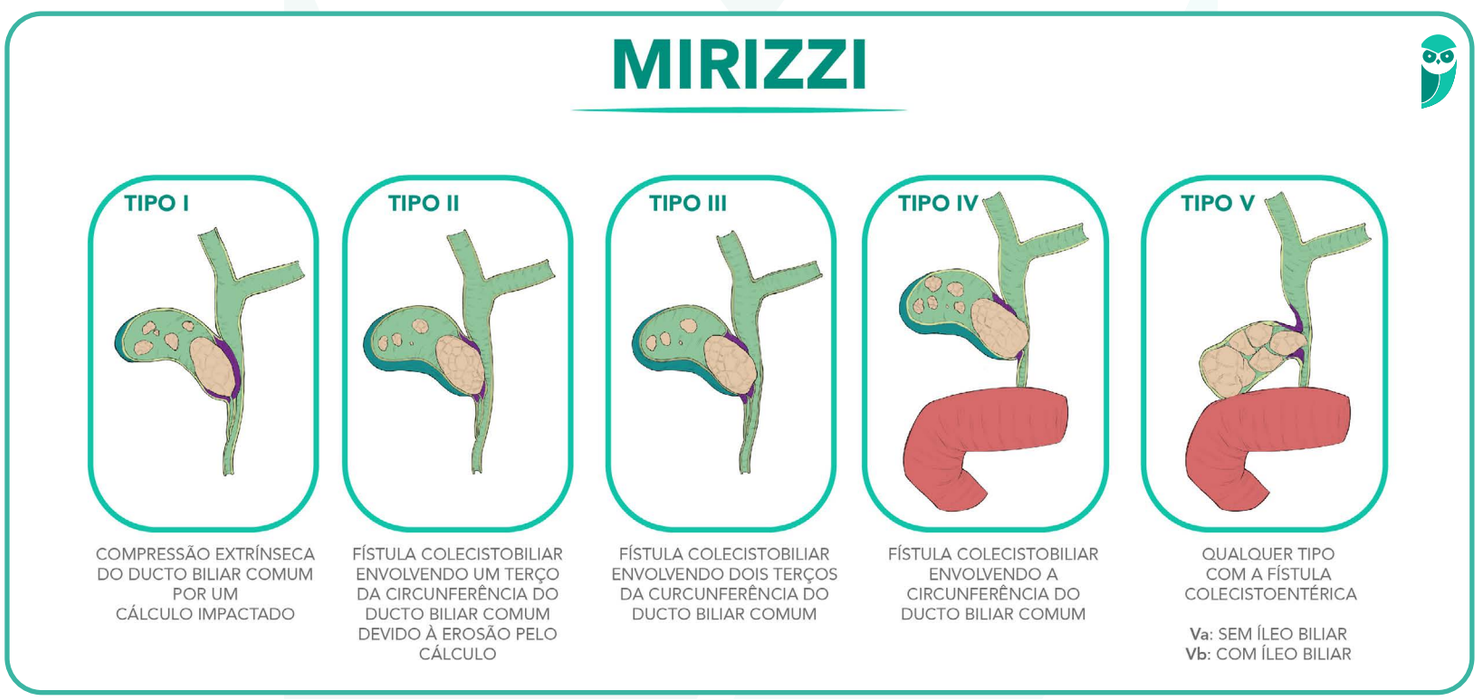
ÍLEO BILIAR



✓ Mulheres e idosos.
✓ Colelitíase, fístula bilioentérica e obstrução intestinal.
✓ Local mais comum da obstrução: íleo terminal.
✓ Tríade de Riegler (radiografia de abdome): obstrução de delgado, cálculos biliares ectópicos e pneumobilia.
✓ Diagnóstico: geralmente por tomografia (obstrução intestinal alta, cálculo > 2,5 cm no íleo terminal, PNEUMOBILIA).
✓ Tratamento: laparotomia e enterotomia.
✓ Pacientes de baixo risco: acrescentar procedimento íleo-biliar (colecistectomia e fechamento da fístula).

6.8 SÍNDROME DE MIRIZZI

A síndrome de Mirizzi é definida como obstrução do ducto hepático comum, causada por compressão extrínseca de um cálculo impactado no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar. Pacientes com síndrome de Mirizzi podem apresentar icterícia, febre e dor no quadrante superior direito.



CAPÍTULO

7.0 DIRETRIZES DE TOKYO

Nas *Diretrizes de Tokyo* são estabelecidos critérios diagnósticos e classificação da gravidade da colecistite e colangite aguda, bem como a conduta terapêutica.

Os critérios de diagnóstico do TG18 para colecistite aguda constituem a combinação de achados clínicos, laboratoriais e de **imagem para diagnóstico**. Repare que, para o diagnóstico definitivo, SEMPRE é necessário um exame de imagem.

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO TG18 / TG13 PARA COLECISTITE AGUDA

A. Sinais locais de inflamação

1) Sinal de Murphy.

2) Massa QSD*/dor/sensibilidade.

*Quadrante superior direito.

B. Sinais sistêmicos de inflamação

1) Febre.

2) PCR Elevado.

3) Contagem elevada de leucócitos.

C. Resultados da imagem

Achados de imagem característicos da colecistite aguda

Diagnóstico suspeito: um item em A + um item em B.

Diagnóstico definitivo: um item em A + um item em B + C.



A classificação da gravidade da colecistite aguda em grau I (leve), grau II (moderado) e grau III (grave) é considerada fator preditivo de mortalidade na admissão. Pacientes com classificação grave apresentam maior tempo de internação hospitalar, maior conversão da laparoscopia para cirurgia aberta, complicações pós-operatórias e mortalidade.

CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DO TG18 / TG13 PARA COLECISTITE AGUDA

Colecistite aguda grau III (grave): associada à disfunção de qualquer um dos seguintes órgãos / sistemas:

1) Disfunção cardiovascular: hipotensão que requer tratamento com dopamina ≥ 5 µg/kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina.

2) Disfunção neurológica: diminuição do nível de consciência.

3) Disfunção respiratória: relação PaO 2/FiO 2 < 300.

4) Disfunção renal: oligúria, creatinina > 2,0 mg/dl.

5) Disfunção hepática: PT - INR > 1,5.

6) Disfunção hematológica: contagem de plaquetas < 100.000/mm³.

Colecistite aguda grau II (moderada): associada a qualquer uma das seguintes condições:

1) Contagem elevada de leucócitos (> 18.000/mm³).

2) Massa macia palpável no quadrante abdominal superior direito.

3) Duração das reclamações > 72h.

4) Inflamação local marcada (colecistite gangrenosa, abscesso pericolecístico, abscesso hepático, peritonite biliar, colecistite enfisematosa).

Colecistite aguda grau I (leve):

A colecistite aguda "Grau I" não atende aos critérios de colecistite aguda "Grau III" ou "Grau II". Também pode ser definida como colecistite aguda em um paciente saudável, sem disfunção orgânica e alterações inflamatórias leves na vesícula biliar, tornando a colecistectomia um procedimento cirúrgico seguro e de baixo risco.

CAPÍTULO

8.0 TRATAMENTO

A base do tratamento da colecistite aguda é a **COLECISTECTOMIA**, preferencialmente por via laparoscópica, e o momento da cirurgia depende da gravidade dos sintomas e do risco cirúrgico do paciente. Além da cirurgia, é primordial os cuidados de suporte com jejum oral, hidratação intravenosa, correção de distúrbios eletrolíticos, analgesia e antibióticos.

Colecistite aguda não complicada: antibioticoprofilaxia.
Colecistite aguda complicada: antibioticoterapia (4 a 7 dias).

TRATAMENTO DA COLECISTITE AGUDA

1- Colecistite aguda - paciente de baixo risco (ASA I e II) = **COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA PRECOCE** (até 72 horas) e antibioticoprofilaxia.

2- Colecistite aguda - paciente de alto risco (ASA III, IV e V) = antibioticoterapia. Se houver falha no tratamento conservador = drenagem da vesícula biliar/colecistectomia.

3- Colecistite aguda – paciente instável = COLECISTOSTOMIA (drenagem percutânea da vesícula biliar guiada por exame de imagem – USG ou TC) e antibioticoterapia. Se houver falha = colecistectomia.

- Colecistectomia após 3 a 6 meses se condições as clínicas forem favoráveis.
- Extração percutânea/litotripsia pela colecistotomia se mantiver alto risco cirúrgico

8.1 TRATAMENTO SEGUNDO AS DIRETRIZES DE TOKYO 2018

As *Diretrizes de Tokyo* propõem que a estratégia de tratamento seja considerada e escolhida após a avaliação da gravidade da colecistite, do estado geral do paciente e da doença subjacente. Para avaliar o risco cirúrgico, utiliza-se como critérios os fatores preditivos (baseado nas disfunções orgânicas), o status físico da ASA e o índice de comorbidade Charlson (ICC). Resumindo, se o paciente é capaz ou não de resistir à cirurgia, com base nesses critérios.

A cirurgia para pacientes com colecistite Tokyo II e III devem ser realizadas em centros avançados e por cirurgiões experientes.

CONDUTA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DE TOKYO

1. BAIXO RISCO (ASA ≤ 2)

TOKYO I: COLECISTECTOMIA PRECOCE.

TOKYO II: COLECISTECTOMIA PRECOCE.

TOKYO III SEM DISFUNÇÃO NEUROLÓGICA/RESPIRATÓRIA/BT

≥ 2 mg/dl:

COLECISTECTOMIA PRECOCE (após reanimação).

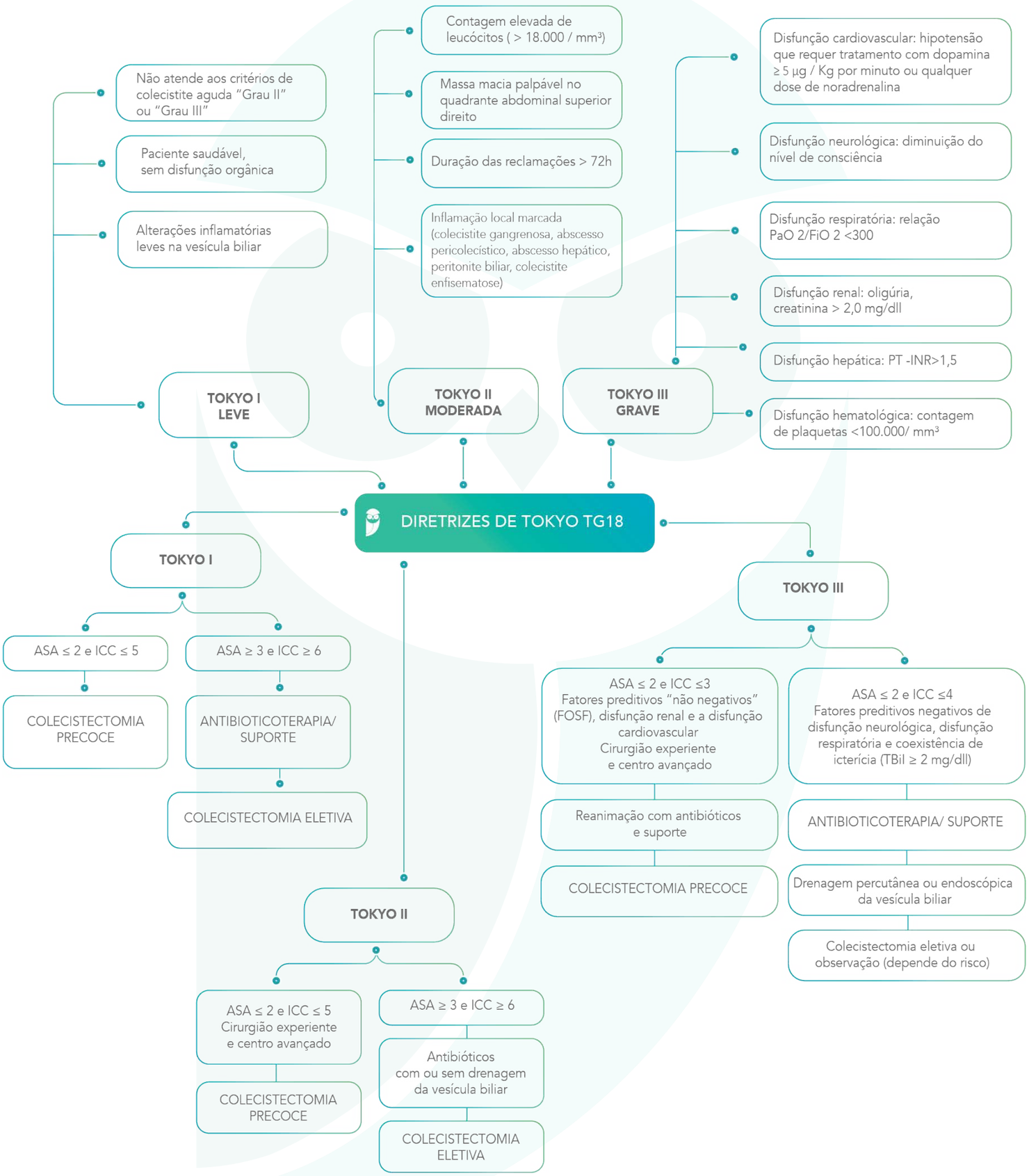
2. ALTO RISCO (ASA ≥ 3)

TOKYO I: ATB = PROGRAMAR COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA ELETIVA.

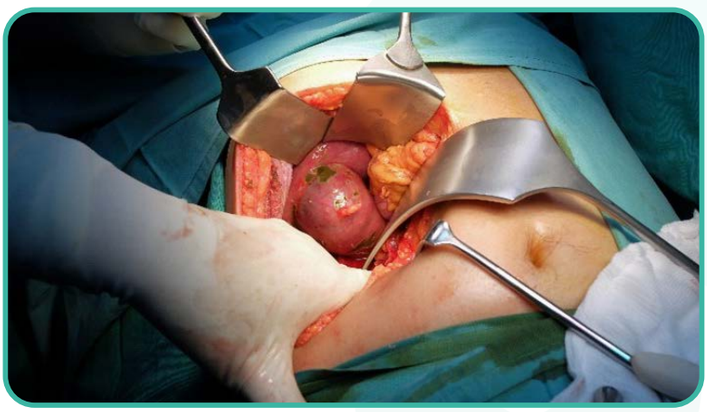
TOKYO II: ATB COM OU SEM COLECISTOSTOMIA = PROGRAMAR COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA ELETIVA.

TOKYO III COM DISFUNÇÃO NEUROLÓGICA/RESPIRATÓRIA/ BT

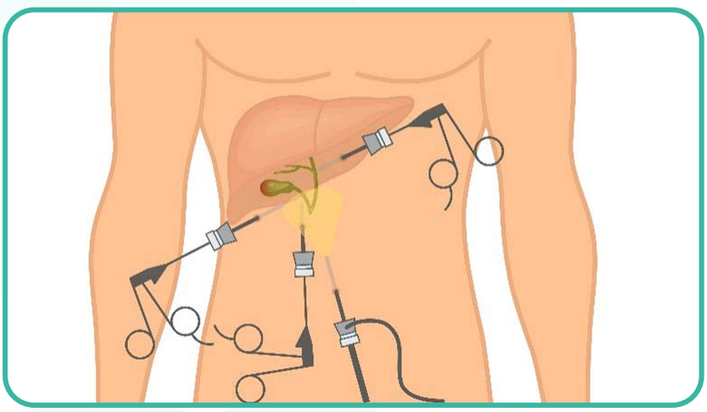
≥ 2 mg/dl: COLECISTOSTOMIA = PROGRAMAR COLECISTECTOMIA SE HOUVER MELHORA DO RISCO CIRÚRGICO.


Não atende aos critérios de colecistite aguda "Grau II" ou "Grau III"
Paciente saudável, sem disfunção orgânica
Alterações inflamatórias leves na vesícula biliar
Contagem elevada de leucócitos (> 18.000 / mm³)
Massa macia palpável no quadrante abdominal superior direito
Duração das reclamações > 72h
Inflamação local marcada (colecistite gangrenosa, abscesso pericolecístico, abscesso hepático, peritonite biliar, colecistite enfisematose)
Disfunção cardiovascular: hipotensão que requer tratamento com dopamina ≥ 5 µg / Kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina
Disfunção neurológica: diminuição do nível de consciência
Disfunção respiratória: relação PaO 2/FiO 2 <300
Disfunção renal: oligúria, creatinina > 2,0 mg/dll
Disfunção hepática: PT -INR>1,5
Disfunção hematológica: contagem de plaquetas <100.000/ mm³
TOKYO I LEVE
TOKYO II MODERADA
TOKYO III GRAVE
DIRETRIZES DE TOKYO TG18
TOKYO I
ASA ≤ 2 e ICC ≤ 5
ASA ≥ 3 e ICC ≥ 6
COLECISTECTOMIA PRECOCE
ANTIBIOTICOTERAPIA/ SUPORTE
COLECISTECTOMIA ELETIVA
TOKYO II
ASA ≤ 2 e ICC ≤ 5 Cirurgião experiente e centro avançado
ASA ≥ 3 e ICC ≥ 6
COLECISTECTOMIA PRECOCE
Antibióticos com ou sem drenagem da vesícula biliar
COLECISTECTOMIA ELETIVA
TOKYO III
ASA ≤ 2 e ICC ≤3 Fatores preditivos "não negativos" (FOSF), disfunção renal e a disfunção cardiovascular Cirurgião experiente e centro avançado
ASA ≤ 2 e ICC ≤4 Fatores preditivos negativos de disfunção neurológica, disfunção respiratória e coexistência de icterícia (TBil ≥ 2 mg/dll)
Reanimação com antibióticos e suporte
ANTIBIOTICOTERAPIA/ SUPORTE
COLECISTECTOMIA PRECOCE
Drenagem percutânea ou endoscópica da vesícula biliar
Colecistectomia eletiva ou observação (depende do risco)

8.2 COLECISTECTOMIA ABERTA X COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA



Colecistectomia aberta (incisão de Kocher) – necrose da parede vesicular. Fonte: Shutterstock.

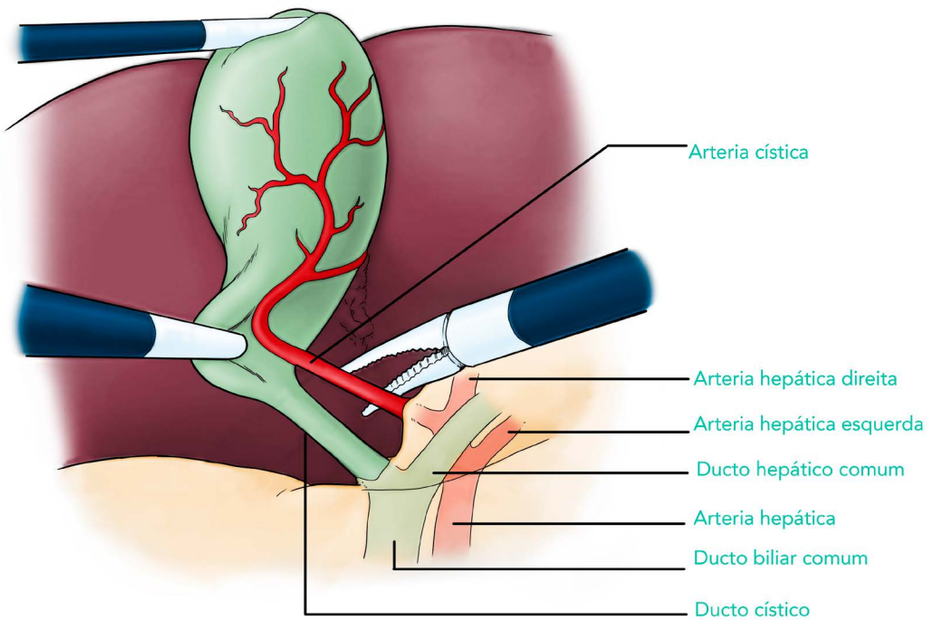


Colecistectomia laparoscópica. Fonte: Shutterstock.

CARACTERÍSTICAS	LAPAROSCOPIA	ABERTA
Infecção de ferida operatória		✔
Maior dor pós-operatória		✔
Obstrução tardia por aderências		✔
Formação de hérnia incisional		✔
Retorno precoce às atividades habituais	✔	
Maior tempo de internação		✔

Colecistectomia aberta: incisão subcostal direita (Kocher) é a mais utilizada.

Devido ao intenso processo inflamatório que dificulta a identificação segura da via biliar, pode ser necessário colecistectomia subtotal, em que a vesícula é seccionada transversalmente e a parede superior da vesícula biliar fica no leito hepático e a mucosa deve ser cauterizada (técnica de Torek).



VISÃO CRÍTICA DA SEGURANÇA: é importante na colecistectomia laparoscópica, e consiste na exposição adequada do trígono de Calot, por meio da tração cranial do fundo da vesícula e ínfero-lateral direita do infundíbulo, dissecando e deixando o trígono livre de todos os tecidos, exceto o ducto cístico e a artéria, que devem ser identificadas antes da secção.

Apenas relembrando os limites do trígono de Calot:

✓ Superior: borda hepática.

✓ Inferior: ducto cístico.

✓ Medial: ducto hepático comum.

✓ Contém a artéria cística.

CAPÍTULO

9.0 COLECISTITE AGUDA ALITIÁSICA

O que você precisa saber de colecistite aguda alitiásica é que, geralmente, acomete **pacientes gravemente enfermos, que necessitam de cuidados intensivos**.

A maioria dos pacientes apresenta múltiplos fatores de risco, sendo os principais: idade avançada, doenças graves (por exemplo, sarcoidose, LES), trauma, uso prolongado de nutrição parenteral total, pós-operatório de cirurgia não biliar, grandes queimados, diabetes e imunossupressão. É responsável por aproximadamente 10% de todos os casos de colecistite aguda e está associada a altas taxas de morbimortalidade, pois há uma maior incidência de complicações (50% podem apresentar gangrena de parede e 10%, perfuração).

É mais frequente no sexo masculino.

Principais fatores de risco para colecistite aguda alitiásica	
Queimaduras	**Nutrição parenteral total (NPT)**
Infecções	Diabetes mellitus
Trauma grave	Insuficiência cardíaca/doença cardíaca coronária
Sepse/hipotensão	Ventilação mecânica
Imunossupressão	Doença renal em estágio terminal
Cirurgia não biliar	Parto

Geralmente, o diagnóstico é confirmado pela **ultrassonografia,** que pode ser realizada na beira do leito, já que a maioria dos pacientes está em estado crítico. Apresenta alterações semelhantes às da colecistite aguda litiásica, com ausência de cálculos biliares.

O tratamento é semelhante ao da colecistite aguda alitiásica:

- Medidas de suporte: jejum, hidratação, correção hidroeletrolítica, controle da dor e antibioticoterapia de largo espectro (colher hemocultura antes).
- **BAIXO RISCO CIRÚRGICO E ANESTÉSICO (ASA ≤ 2):** colecistectomia VLP.
- **ALTO RISCO CIRÚRGICO E ANESTÉSICO (ASA ≥ 3), INSTÁVEIS**: COLECISTOSTOMIA (drenagem percutânea da vesícula biliar guiada por exame de imagem). Aproximadamente 90% dos pacientes melhoram com a drenagem. O dreno pode ser retirado após resolução da colecistite e drenagem mínima (< 10 ml, geralmente, após 4 a 6 semanas). Como a recorrência é baixa, não está indicada colecistectomia posteriormente.

CAPÍTULO

10.0 COLECISTITE AGUDA NA GESTANTE

A colecistite aguda é a segunda causa de abdome agudo não obstétrico na gestante (1-6: 10.000), lembrando que a primeira é a apendicite.

O tratamento ideal para a colecistite aguda depende da idade gestacional:

GESTANTE COM COLECISTITE

✓ Baixo risco (ASA ≤ 2):

- 1º e 2º trimestre: colecistectomia laparoscópica.
- 3° trimestre: antibióticos, postergar a colecistectomia para o pós-parto (6 semanas), pelo risco de trabalho de parto prematuro.

✓ Alto risco (ASA ≥ 3), instável: drenagem percutânea (colecistostomia).

A colecistectomia laparoscópica, em qualquer trimestre de gestação, é a técnica preferida em mulheres grávidas.

COLANGITE AGUDA

CAPÍTULO
11.0 INTRODUÇÃO

A colangite aguda ou colangite ascendente é uma síndrome clínica, caracterizada por febre, icterícia e dor abdominal que se desenvolve como resultado de **obstrução, estase e infecção no trato biliar.**

CAPÍTULO
12.0 EPIDEMIOLOGIA

Causas mais frequentes de obstrução biliar:

✓ Cálculos biliares (28% a 70%)

✓ Estenose biliar benigna (5% a 28%)

✓ Malignidade (10% a 57%)

CAPÍTULO
13.0 FISIOPATOLOGIA

OBSTRUÇÃO BILIAR



A colangite aguda é causada principalmente por infecção bacteriana em um paciente com obstrução biliar. Os organismos geralmente ascendem do duodeno quando os mecanismos de barreira à entrada de bactérias no sistema biliar são rompidos.

Outro fator importante: aumento da pressão intraluminal. Pressões entre 18 cmH2O e 29 cmH2O causam fluxo biliar retrógrado, permitindo que a bile infectada atinja o sistema venoso e linfático e deflagre a bacteremia. Pressão normal: 10 a 14 cmH2O.

De um modo geral, a flora bacteriana na colangite aguda é **polimicrobiana**. A ***E. coli*** é a principal bactéria Gram negativa isolada (25% a 50%), seguida pela ***Klebsiella*** (15% a 20%) e *Enterobacter* (5% a 10%). Entre as Gram positivas, a mais comuns são as espécies de *Enterococcus* (10% a 20%). Bacilos gram-negativos (*Pseudomonas*) e anaeróbios, como *Bacteroides* e *Clostridium*, também podem estar presentes como parte de uma infecção mista.

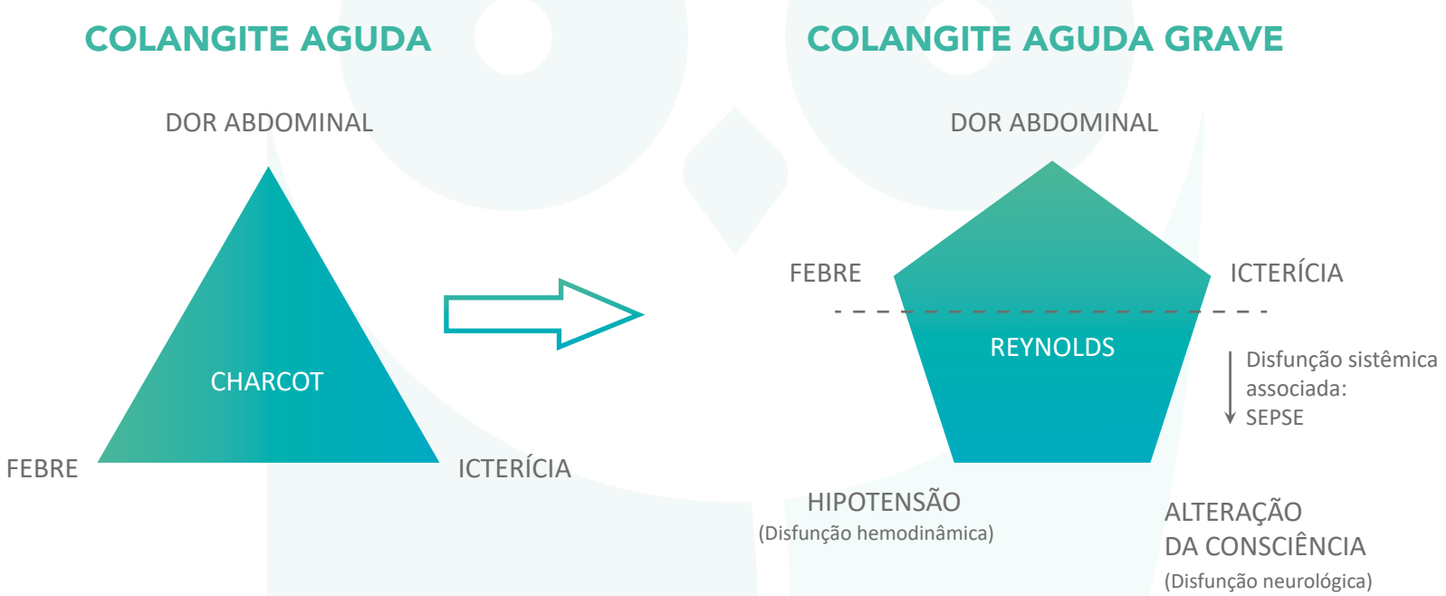
CAPÍTULO

14.0 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

DECORE a tríade de Charcos e a pêntade de Reynolds, características da colangite aguda.

TRÍADE DE CHARCOT: dor abdominal, febre e icterícia (presente em 50% a 75% dos casos). A dor abdominal não apresenta sinais de peritonite.

PÊNTADE DE REYNOLDS: dor abdominal, febre, icterícia, hipotensão e alteração do sensório (sonolência, confusão mental, torpor). Presente na colangite aguda grave.



CAPÍTULO

15.0 EXAMES COMPLEMENTARES

15.1 EXAMES LABORATORIAIS

As principais alterações laboratoriais são:

- ✓ leucocitose com desvio à esquerda;
- ✓ aumento da proteína C reativa (PCR);
- ✓ elevações da fosfatase alcalina, gama-glutamil transpeptidase e de bilirrubinas (predominantemente a fração direta).
- ✓ pode haver um aumento importante das transaminases, se houver necrose aguda de hepatócitos e formação de microabscessos no fígado.

15.2 EXAMES DE IMAGEM

Para o diagnóstico definitivo de colangite aguda, é necessário, obrigatoriamente, exame de imagem que demonstre dilatação da via biliar ou até mesmo o fator obstrutivo.

COLANGITE AGUDA = história clínica + exame físico + laboratório.

EXAME DE IMAGEM



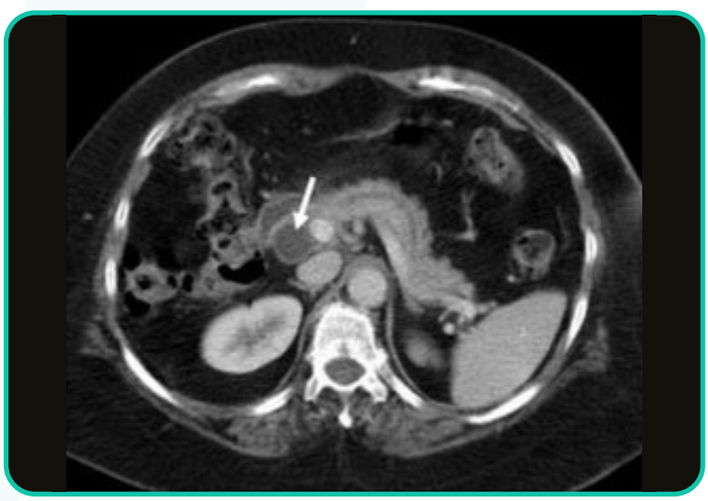
Coledocolitíase e dilatação da via biliar.
Fonte: prova de acesso direto USP RP 2011.

ULTRASSONOGRAFIA

Na ultrassonografia, as alterações mais importantes incluem a dilatação biliar e visualização de cálculos no ducto biliar. Geralmente, consideramos um colédoco dilatado a partir de 6 mm.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

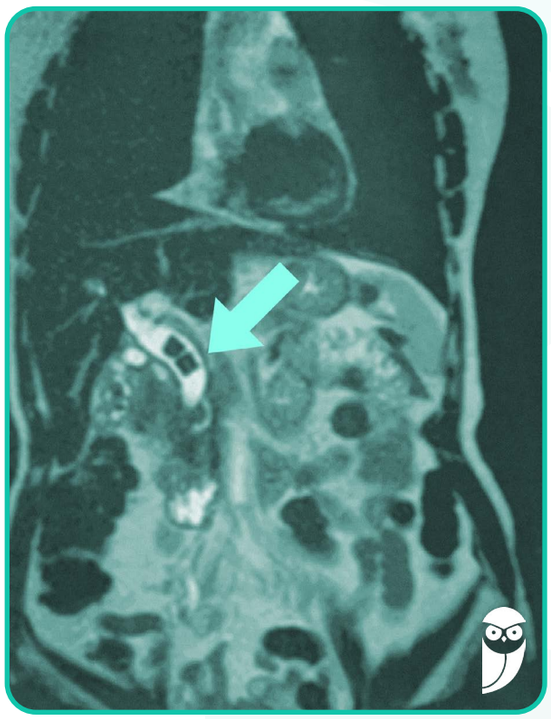
A tomografia tem alta sensibilidade para identificar a dilatação do ducto biliar e pode identificar estenose biliar (por exemplo, carcinoma biliar, câncer de pâncreas ou colangite esclerosante), mas tem baixa sensibilidade para cálculos do ducto biliar. É útil no diagnóstico de complicações locais, como abscesso hepático ou trombose da veia porta. Em alguns casos mais graves, é possível ver a presença de aerobilia por produção de gás bacteriano dentro da árvore biliar obstruída.



Colédoco dilatado.
Fonte: prova de acesso direto SES PE 2020.

COLANGIORESSONÂNCIA (CRNM)

A colangiorressonância pode delinear claramente o ducto biliar sem o uso de contraste e **POSSUI MAIOR PRECISÃO DIAGNÓSTICA NA IDENTIFICAÇÃO DA CAUSA DA OBSTRUÇÃO BILIAR** quando comparada à TC e à ultrassonografia. É, geralmente, solicitada quando a ultrassonografia ou a tomografia computadorizada não fecham o diagnóstico. É um exame que oferece excelente acurácia diagnóstica, com sensibilidade e especificidade de 87% e 92%, respectivamente, mas tem baixa disponibilidade na maioria dos serviços e não possibilita o tratamento como a CPRE.



Coledocolitíase.



Múltiplos cálculos na via biliar.
Fonte: imagem adaptada do UpToDate.

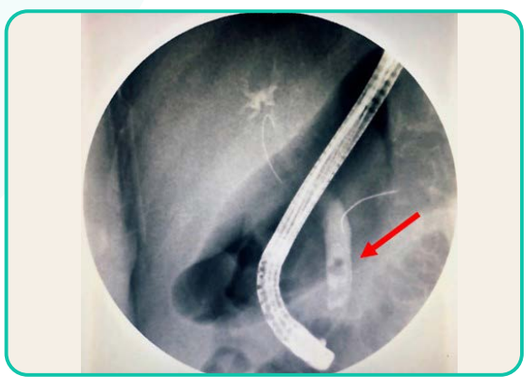
ECOENDOSCOPIA – ULTRASSOM ENDOSCÓPICO

A ecoendoscopia tem excelente acurácia para o diagnóstico de coledocolitíase. Apresenta sensibilidade e especificidade de 97% e 90%, respectivamente. Em relação à colangiorressonância, tem a vantagem de identificar melhor cálculos pequenos (< 6 mm), mas também é um exame pouco disponível.

COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA - CPRE

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) utiliza a endoscopia e a fluoroscopia para injetar contraste por meio da ampola de Vater. É um exame **diagnóstico e terapêutico para drenar a via biliar e retirar de cálculos**, geralmente realizada após confirmação diagnóstica da colangite por exames de imagem menos invasivos (ultrassom, tomografia, colangiorressonância).

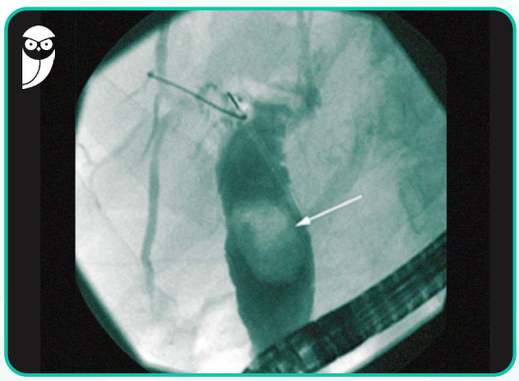
Não se esqueça de que a CPRE é um exame invasivo e apresenta complicações, como pancreatite aguda (mais comum), colangite, perfuração duodenal e sangramento, quando a esfincterotomia é realizada (hemorragia digestiva alta exteriorizada por hematêmese e/ou melena).



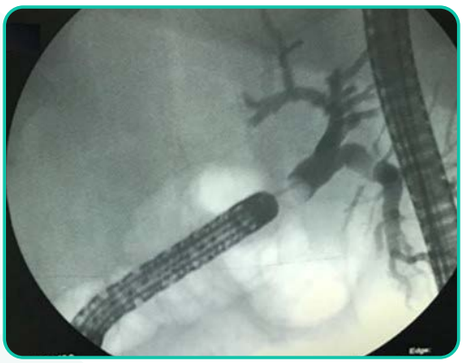
Coledocolitíase.
Fonte: Shutterstock.



Via biliar dilatada com múltiplos cálculos.
Fonte: prova de acesso direto SURCE 2017.



Cálculo grande em colédoco com importante dilatação da via biliar.
Fonte: imagem adaptada do UpToDate.



Coledocolitíase e dilatação da via biliar: imagem do "cálice invertido".
Fonte: acervo pessoal dra. Renatha Paiva.

CAPÍTULO

16.0 DIRETRIZES DE TOKYO

Meu querido Aluno, apesar de as provas cobrarem as Diretrizes de Tokyo (TG – *Tokyo Guidelines*) principalmente em questões referentes à colecistite aguda, não podemos esquecer que as diretrizes também estabelecem tanto critérios para diagnosticar como para classificar a gravidade da colangite aguda.

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO TG18/TG13 PARA COLANGITE AGUDA

A. Inflamação sistêmica

1. Febre (> 38 °C) e/ou calafrios.
2. Dados laboratoriais: evidência de resposta inflamatória:
   - ► contagem anormal dos leucócitos: < 4 ou > 10 x 1.000 / µL;
   - ► aumento PCR ≥ 1 mg/dL;
   - ► outras alterações indicando inflamação.

B. Colestase

1. Icterícia (bilirrubina ≥ 2 mg/dL).
2. Dados laboratoriais: marcadores de lesão hepática anormais (FA, GGT, TGO ou TGP > 1,5 vezes o limite superior do normal).

C. Imagem

1. Dilatação biliar.
2. Evidência da etiologia na imagem (estenose, cálculo, stent etc.).

Diagnóstico suspeito: um item em A + um item em B ou C.

Diagnóstico definitivo: um item em A, um item em B e um item em C.

Os critérios de classificação de gravidade do TG18 para a colangite aguda são importantes para prever o prognóstico e determinar uma estratégia de tratamento, especialmente para identificar pacientes que necessitam de drenagem precoce da via biliar. **As taxas de mortalidade para pacientes com colangite aguda grave é de aproximadamente 20% a 30%.**



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE DO TG18 PARA COLANGITE AGUDA

Colangite aguda grau III (grave): associada ao aparecimento de disfunção, pelo menos em qualquer um dos seguintes órgãos/sistemas:

1. Disfunção cardiovascular: hipotensão requerendo dopamina ≥ 5 µg/kg por minuto ou qualquer dose de noradrenalina.
2. Disfunção neurológica: perturbação da consciência.
3. Disfunção respiratória: relação PaO 2 / FiO 2 < 300.
4. Disfunção renal: oligúria, creatinina sérica > 2,0 mg/dl.
5. Disfunção hepática: PT - INR > 1,5.
6. Disfunção hematológica: contagem de plaquetas < 100.000/mm^3.

Colangite aguda grau II (moderada): associada a duas das seguintes condições:

1. Contagem de leucócitos anormais (> 12.000/mm^3, < 4.000/mm^3).
2. Febre alta (≥ 39 °C).
3. Idade (≥ 75 anos).
4. Hiperbilirrubinemia (bilirrubina total ≥ 5 mg/dl).
5. Hipoalbuminemia (< DST* × 0,7).

Colangite aguda grau I (leve).

A colangite aguda "Grau I" não atende aos critérios de colangite aguda "Grau III (grave)" ou "Grau II (moderado)" no diagnóstico inicial.

* DST: limite inferior do valor normal.

CAPÍTULO

17.0 TRATAMENTO

O tratamento da colangite aguda baseia-se em:

✓ Medidas de suporte: jejum, hidratação intravenosa, correção de distúrbios eletrolíticos e controle da dor.

✓ Antibioticoterapia endovenosa: cobrir bactérias Gram negativas, positivas e anaeróbios.

✓ **Drenagem da via biliar.**

17.1 DRENAGEM DA VIA BILIAR

É comum cair em prova um caso clínico de colangite aguda e questionar sobre o tratamento, que quase sempre envolve drenagem da via biliar urgente.

A drenagem da via biliar é primordial nos pacientes com colangite aguda. As vias de drenagem mais utilizadas são a endoscópica (CPRE), transparieto-hepática e a via cirúrgica. Vamos falar um pouco de cada uma.

DRENAGEM ENDOSCÓPICA - CPRE

A CPRE (colangiopancreatografia retrógrada endoscópica) com drenagem biliar transpapilar é o tratamento de escolha, **PADRÃO-OURO**, para a colangite aguda.



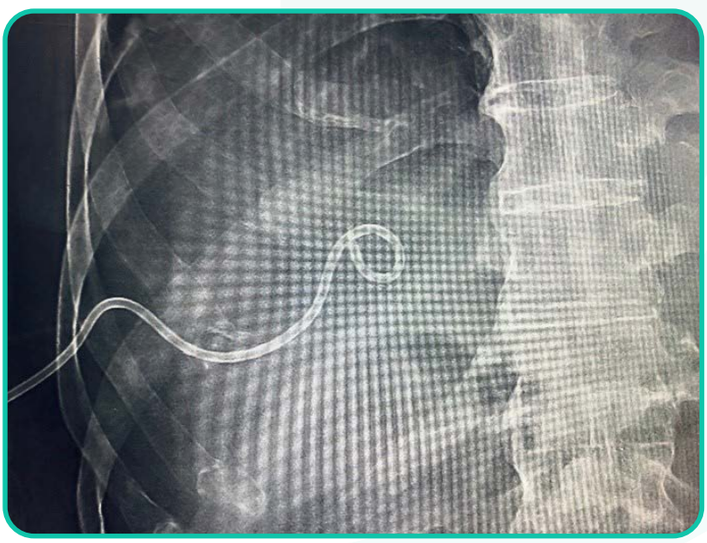
CPRE: extração de cálculo impactado no colédoco distal. Fonte: acervo pessoal Dra. Renatha Paiva.



Extração de cálculo pela CPRE.
Fonte: Shutterstock.

DRENAGEM TRANSPARIETO-HEPÁTICA - DTPH

A drenagem trans-hepática biliar percutânea, guiada por ultrassonografia, é realizada quando a drenagem endoscópica não está disponível ou é malsucedida ou inacessível (por exemplo, anastomose em Y de Roux ou ressecção de Whipple ou estreitamento duodenal). No entanto, **requer dilatação da via biliar intra-hepática**, é mais invasiva em comparação com a CPRE e não deve ser realizada em pacientes com coagulopatias.



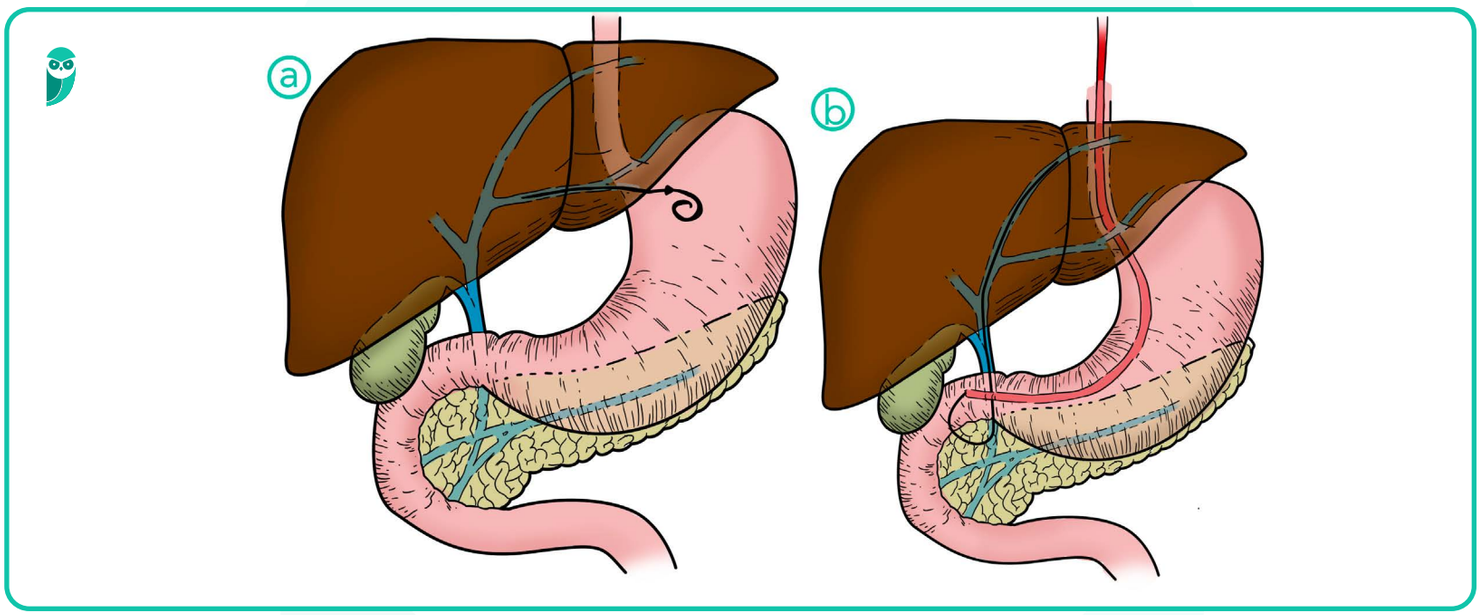
Drenagem trans-hepática percutânea.
Fonte: Shutterstock.



Prótese trans-hepática percutânea.
Fonte: Shutterstock.

DRENAGEM POR ECOENDOSCOPIA

Outra alternativa para o tratamento da colangite é a colangiopancreatografia guiada por ultrassom endoscópico, com drenagem biliar e colocação de stent. Indicada para pacientes com alto risco de complicações com a CPRE ou CTPH, na falha destas, na impossibilidade de acesso endoscópico devido à anatomia cirúrgica alterada (ex. Y de Roux) ou obstrução de tumores duodenais e ampulares.

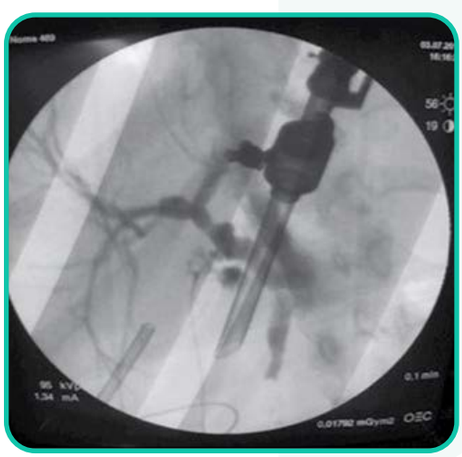


Drenagem da via biliar por ecoendoscopia.
a) hepatogastrostomia; b) coledocoduodenostomia.

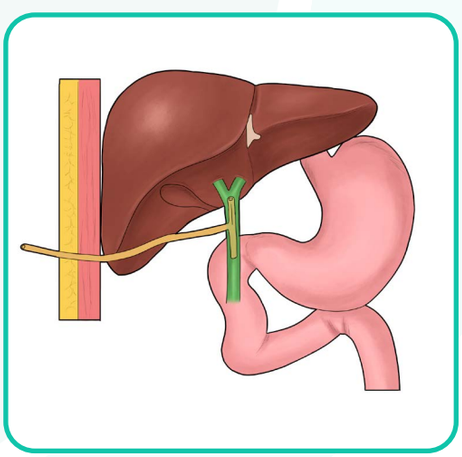
DRENAGEM CIRÚRGICA

A drenagem cirúrgica da via biliar pode ser feita por via aberta ou laparoscópica, mas é reservada para pacientes em que outros métodos de drenagem biliar (CPRE, DTPH) não podem ser realizados ou falharam.

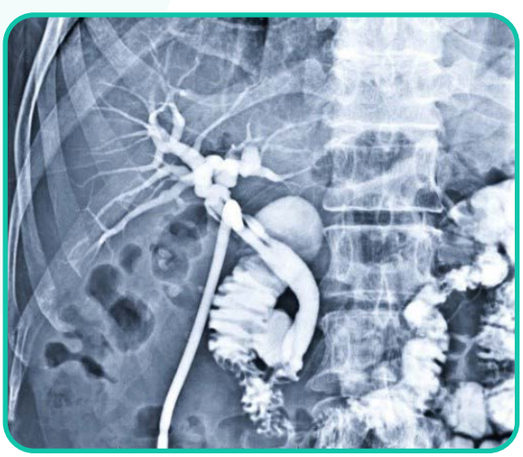
Por tratar-se de pacientes geralmente graves, a técnica mais realizada é a coledocotomia e colocação de um tubo T (dreno de Kehr). Em pacientes hemodinamicamente estáveis, uma colecistectomia e a retirada do cálculo obstrutivo podem ser realizadas ao mesmo tempo.



A - Colangiografia intraoperatória: obstrução distal (cálice invertido).
Fonte: prova de acesso direto FAMEMA 2019.



B - Coledocotomia e colocação do dreno de Kehr.



C - Colangiografia pós-retirada do cálculo e drenagem com Kehr.
Fonte: Shutterstock.



INDICAÇÃO DERIVAÇÃO BILEODIGESTIVA

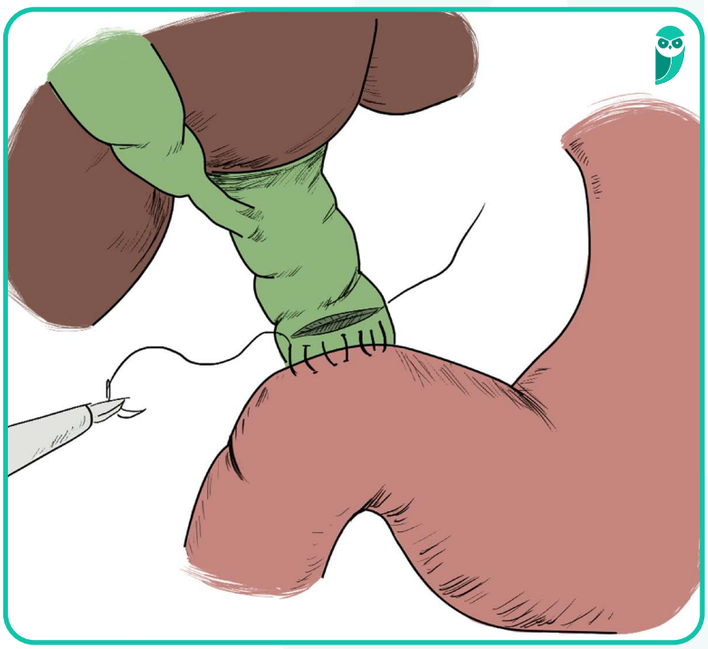
✓ Necessária estabilidade hemodinâmica.

✓ Via biliar dilatada (> 2 cm) e/ou com múltiplos cálculos.

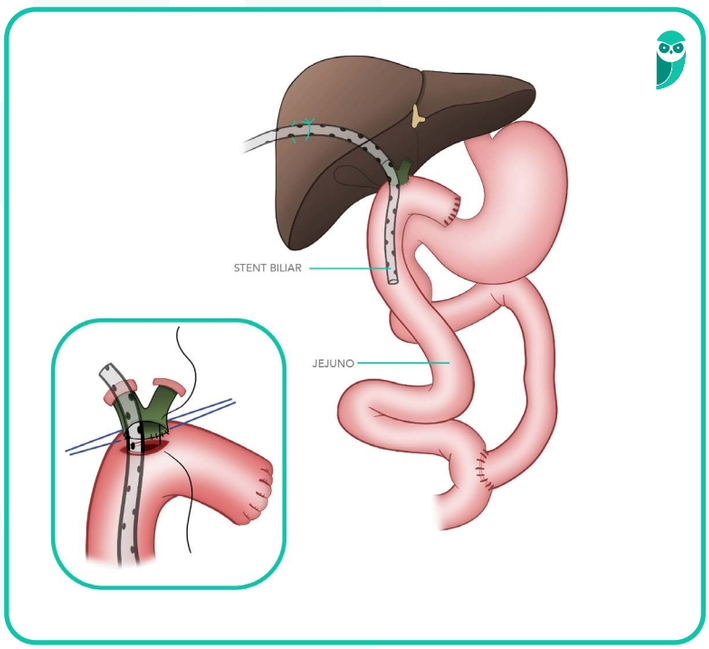
✓ Técnicas:

- Hepatoduodenostomia látero-lateral: única anastomose e tem acesso endoscópico posteriormente. Maior risco de colangite recorrente, processo conhecido como síndrome de Sump (restos alimentares provenientes do duodeno, que obstruem a anastomose ou ducto pancreático).
- Hepatojejunostomia em Y de Roux: menor risco de refluxo e colangite, mas fica inacessível ao endoscópico.

HEPATODUODENOANASTOMOSE



HEPATOJEJUNOANASTOMOSE



Segundo as diretrizes de Tokyo 2018, o momento da drenagem biliar depende da gravidade da doença.

Colangite grau I (leve): na maioria dos casos, o tratamento inicial incluindo antibióticos é suficiente e a maioria dos pacientes não necessita de drenagem biliar. No entanto, a drenagem biliar deve ser considerada se um paciente não responder ao tratamento inicial nas 24 horas iniciais.

Colangite grau II (moderada): é indicada uma drenagem biliar endoscópica (CPRE) ou percutânea trans-hepática precoce.

Colangite grau III (grave - supurativa): é indicada uma drenagem biliar endoscópica (CPRE) ou percutânea trans-hepática **URGENTE** (dentro de 24 horas). Melhorar a condição do paciente com tratamento inicial e controle respiratório/circulatório para a drenagem.

Se for necessário tratamento para a etiologia subjacente, deve ser realizado após resolução da colangite aguda e melhora do estado geral do paciente.

17.2 TRATAMENTO DA CAUSA DA COLANGITE

A CPRE pode ser efetiva para extração dos cálculos, podendo evitar um procedimento aberto inicial, mas cerca de 50% dos pacientes podem ter recidiva se não tratados também com colecistectomia. Esta deve ser realizada, preferencialmente, **na mesma internação hospitalar**.

Posteriormente à resolução da colangite, as opções cirúrgicas para pacientes com obstrução biliar maligna incluem: ressecção (por exemplo, ressecção de Whipple ou ducto biliar), derivação biliodigestiva e drenagem do ducto com stent biliar.



RESUMINDO

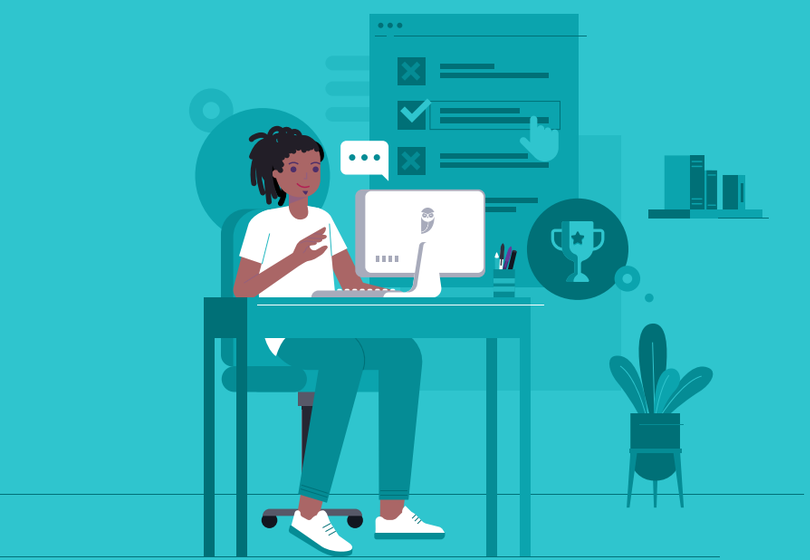
Cálculos biliares: colecistectomia eletiva, preferencialmente na mesma internação, após a resolução da colangite, para evitar recorrência.

Estenose biliar benigna, lesão iatrogênica do ducto biliar: terapia endoscópica ou reparo cirúrgico.

Estenoses maligna: ressecção, biliodigestiva e colocação de stent.

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://bit.ly/2OCGlcu

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

19.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20ª edição
2. Uptodate:
3. As manifestações clínicas e diagnóstico de colecistite
4. Tratamento de colecistite calculosa aguda
5. O diagnóstico e tratamento da colecistite acalculosa
6. Técnicas de colecistectomia.
7. Íleo biliar
8. Abscesso hepático piogênico
9. Colangite aguda: manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento
10. Colangite piogênica recorrente
11. Diretrizes de Tóquio 2018 (TG18):
12. http://www.jshbps.jp/modules/en/index.php?content_id=47
13. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.516
14. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.515
15. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.518
16. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.512
17. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jhbp.509

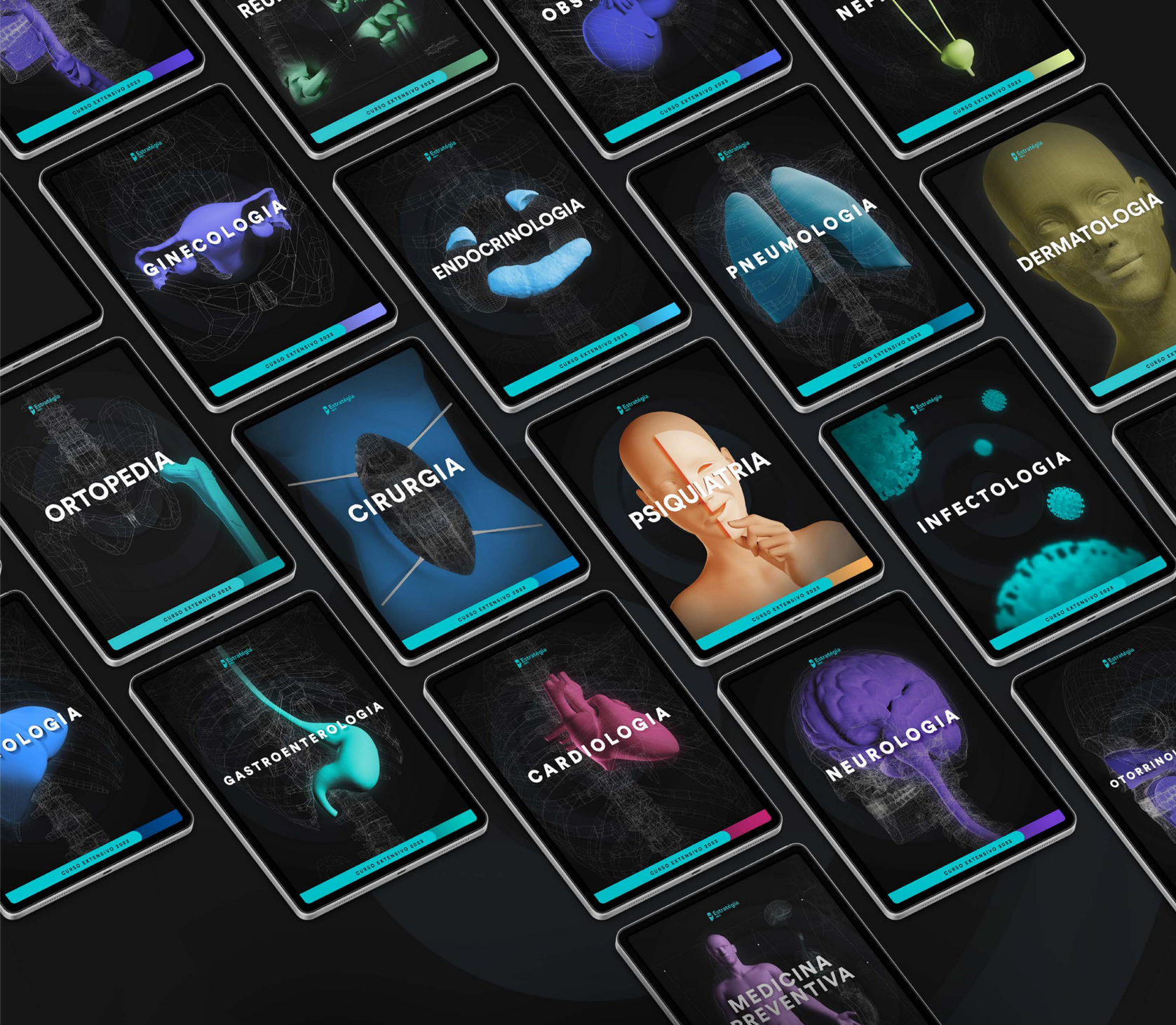
CAPÍTULO

20.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, Doenças das Vias Biliares, dentre elas a Colecistite e Colangite Aguda, é um tema frequente nas provas de residência médica. Apesar de ser um resumo, ele está com os pontos mais importantes que você precisa saber para ir bem nas provas

Abraços,

Renatha Paiva



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED